

Je suis en premier stage de scanner, lors du deuxième stage de première année, dans un hôpital public du Var. Le service d'imagerie est organisé de telle manière que la salle d'attente centrale est commune aux 2 scanners, à l'IRM et aux 3 salles de radio. Le service de scanner étant en pénurie de manipulateurs en électroradiologie médicale, il fonctionne en binôme infirmière de pool + manip.

Lors de ce stage est pris en charge Monsieur X, âgé de 69 ans, qui se présente dans le service pour la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien. Il est conscient, alerte, orienté, mobile sans aide et la communication est facile. L'examen est prescrit à la suite de la découverte d'une masse hépatique potentiellement suspecte lors d'une échographie. À ce stade, le patient ne présente pas de signe clinique particulier et aucune information précise ne lui a été communiquée quant à la nature de cette découverte.

À son arrivée en cabine, l'infirmière prépare le matériel nécessaire à la pose d'une voie veineuse périphérique : cathéter rose, antiseptique cutané, strips et pansement transparent. La pose de la voie veineuse se déroule sans difficulté. De mon côté, je prépare le produit de contraste iodé en adaptant le volume au poids du patient. Le produit est installé dans un injecteur à double seringue, le dispositif est purgé, puis raccordé à la voie veineuse.

Le patient est ensuite installé sur la table d'examen. Je vérifie à nouveau qu'il ne porte aucun objet métallique pouvant générer des artefacts, je réalise le centrage et je lui réexplique le déroulement du scanner : l'injection du produit de contraste, la sensation de chaleur possible et les consignes d'apnée. Je m'assure qu'il est confortablement installé. Le radiologue modifie le protocole initialement prévu et demande la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien, dans l'objectif de rechercher une éventuelle origine primitive à la pathologie hépatique suspectée. Le protocole comprend une acquisition sans injection, suivie d'une injection avec des temps artériel et portal précis, ainsi que la possibilité d'une phase tardive selon les images obtenues.

Pendant l'examen, je suis positionné à la console et concentré principalement sur les aspects techniques. Mon attention porte sur le bon déroulement de l'injection, le respect du protocole et la qualité des acquisitions. Je vérifie notamment que l'exploration couvre l'ensemble des zones demandées et qu'il n'y ait pas d'artefact de flou cinétique. À ce moment-là, mon rôle n'est pas d'interpréter les images, mais de m'assurer que l'examen est complet et conforme à la demande médicale.

Au cours de cette phase, la manipulatrice encadrante, grâce à son expérience, identifie rapidement une anomalie au niveau du pancréas et remonte sur certaines coupes afin de mieux visualiser la zone. Ce geste s'inscrit dans le rôle attendu du manipulateur expérimenté. En 2018, une étude menée à l'Hôpital Saint-Joseph de Paris a d'ailleurs montré que les manipulateurs, par leur regard attentif sur chaque examen réalisé, sont

capables de repérer des anomalies – appelées incidentalomes – qui peuvent modifier la prise en charge du patient. Cette capacité de détection fait partie intégrante des compétences professionnelles attendues, même si elle reste bien distincte de l'interprétation diagnostique qui demeure du ressort exclusif du radiologue.

Dans notre cas, le geste réalisé dans le cadre habituel du contrôle des acquisitions rend la présence d'une volumineuse masse pancréatique particulièrement visible. Même sans être en position d'interprétation, cette situation laisse supposer une pathologie d'importance. Cette prise de conscience ne résulte pas d'une recherche volontaire de ma part, mais du déroulement normal de l'examen et de l'expertise de la manipulatrice.

C'est à partir de ce moment que je prends conscience de l'écart entre ce que je vois à l'écran et ce que le patient ignore encore. Cette asymétrie d'information est, en réalité, inhérente à la relation soignant-soigné : le soignant est celui qui sait, qui prend en charge, tandis que le patient est dans l'attente, dépendant des informations qu'on voudra bien lui transmettre. Cette situation est d'autant plus délicate qu'en imagerie médicale, les patients ignorent généralement qu'un examen peut révéler des anomalies totalement inattendues, sans lien avec ce qu'ils ressentent ou les symptômes qui ont motivé la prescription.

Cette situation fait écho à une expérience personnelle antérieure : l'année précédente, la grand-mère d'une amie proche était décédée rapidement d'un cancer du pancréas découvert tardivement. Sans établir de lien médical direct, cette expérience m'a rendu particulièrement sensible à ce type de découverte et à ce qu'elle peut représenter pour un patient.

Je porte alors une attention accrue à mon attitude verbale, paraverbale et non verbale afin de ne rien laisser transparaître. Cette vigilance est renforcée par une discussion que j'avais eue quelque temps auparavant avec une manipulatrice du service, qui m'avait relaté un ancien examen scanner pédiatrique au cours duquel une pathologie grave avait été découverte, et la manière dont certains éléments non verbaux avaient été perçus et interprétés par l'entourage présent. Cet échange m'avait sensibilisé à l'importance du paraverbal et du non verbal dans la relation soignant-soigné.

Concrètement, je m'efforce de maintenir un discours habituel, un ton de voix stable et une attitude corporelle neutre. Toutefois, avec le recul, je me rends compte du caractère paradoxal de cette démarche. En cherchant à contrôler consciemment mon non verbal, je prends le risque de modifier subtilement mon comportement et de rendre la relation moins naturelle.

Cette difficulté n'est pas propre à ma situation. Guy Barrier, chercheur spécialisé en analyse gestuelle, souligne qu'il n'est jamais évident d'identifier les émotions subtiles d'autrui, et surtout, que nous avons rarement conscience de nos propres signes

corporels. De plus, les patients peuvent interpréter de multiples façons le comportement des soignants, en compensant parfois le manque d'informations reçues par leurs propres impressions déduites du contexte non verbal. Certains patients, notamment en situation de stress ou d'attente de résultats, peuvent être particulièrement attentifs au moindre détail et suranalyser le comportement des soignants, tandis que d'autres, comme Monsieur X, ne semblent rien percevoir. Le patient n'a exprimé aucune inquiétude ni posé de question particulière, sans que je puisse savoir ce qu'il a réellement ressenti intérieurement.

Cette situation m'amène à remettre en question ma manière de gérer ces moments. Dans le contexte du scanner, il n'est pas possible de prendre du recul immédiatement, car le patient reste installé sur la table dans l'attente d'une décision du radiologue concernant d'éventuelles acquisitions complémentaires. Une piste de réflexion serait de maintenir une posture d'attente neutre et stable, en s'appuyant sur des repères professionnels constants. Plutôt que de chercher à contrôler directement mon non verbal, une approche possible consisterait à m'ancrer davantage dans des routines techniques et relationnelles déjà intégrées : vérification des paramètres, contrôle de la qualité d'image, phrases simples et habituelles pour informer le patient de l'avancée de l'examen, attitude identique à celle adoptée lors de tout autre scanner.

Cette approche trouve d'ailleurs un écho dans la littérature professionnelle. Une étude publiée en 2019 dans *Cancer/Radiothérapie* sur la relation entre manipulateurs, radiologues et patients conclut qu'il n'existe pas une seule « bonne pratique », mais plutôt des attitudes à éviter et des aptitudes à développer. Ce qui ressort clairement, c'est que la maîtrise technique reste indispensable et qu'un climat de confiance passe par l'organisation du service autour du patient. L'automatisation de gestes professionnels cohérents semble ainsi constituer un point d'ancrage plus fiable que le contrôle conscient du langage corporel.

Toutefois, cette stratégie présente ses limites. S'enfermer exclusivement dans la technique pourrait créer une distance excessive ou une froideur perçue comme inhabituelle par certains patients. Il s'agit donc de trouver un équilibre délicat : les automatismes professionnels peuvent offrir un cadre rassurant et une cohérence comportementale, mais ils ne constituent pas nécessairement la seule réponse adaptée. La relation authentique avec le patient ne se résume pas à l'application mécanique de routines, même si celles-ci peuvent servir de point d'appui dans les situations émotionnellement chargées. Cette expérience soulève finalement plus de questions qu'elle n'apporte de réponses définitives sur la meilleure façon de gérer ces moments d'asymétrie d'information.

Cette expérience m'a également rappelé le cadre déontologique dans lequel s'inscrit le métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Le secret professionnel est au cœur de nos obligations. L'article R.4127-4 du Code de déontologie médicale précise

qu'il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel dans l'exercice de sa profession : non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Ce principe s'étend aux manipulateurs en électroradiologie médicale et englobe explicitement les images médicales. L'article 226-13 du Code pénal ne laisse aucune ambiguïté : toute révélation d'information à caractère secret est sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Par ailleurs, le rôle du manipulateur est strictement défini par l'article R4351-3 du Code de la santé publique. Le manipulateur participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement, mais il doit préciser que le diagnostic sera établi par un médecin radiologue. Autrement dit, s'il est garant de la qualité technique de l'examen, il n'a ni la compétence ni la légitimité d'interpréter les images ou d'informer le patient sur leur signification. Cette délimitation des rôles constitue une protection à la fois pour le patient, qui doit recevoir une information adaptée et validée, et pour le professionnel.

Face à ce type de situation, plusieurs pistes d'amélioration émergent de la littérature professionnelle et des recommandations institutionnelles. La Société Française de Radiologie, dans ses réflexions éthiques publiées en 2023, recommande qu'une prise en charge correcte devrait inclure l'information au patient, en amont de l'examen, qu'il sera revu pour recevoir de plus amples informations après son scanner. Cette consultation post-examen systématique par le radiologue permet de réduire l'asymétrie d'information et l'anxiété du patient, en évitant qu'il ne reparte sans explication.

Dans le cas que j'évoque, le radiologue est effectivement allé voir le patient après l'examen. Cependant, entre la fin de l'acquisition des images et cette entrevue s'est écoulée une attente qui m'a semblé interminable. Durant ce laps de temps, j'ai dû attendre la validation des images par le radiologue, reconduire le patient en cabine et retirer la voie veineuse, tout en tentant de maintenir une attitude professionnelle naturelle. Ces gestes techniques habituels prenaient soudain une dimension particulière : chaque parole, chaque silence, chaque mouvement me semblaient susceptibles d'être interprétés par le patient. La maîtrise simultanée de mes gestes techniques et de ma communication, tant verbale que non verbale, constituait un véritable défi dans ce contexte chargé émotionnellement.

De plus, les recommandations internationales, notamment celles de la Commission présidentielle américaine pour l'étude des questions de bioéthique, insistent sur l'importance d'anticiper les découvertes fortuites par une information préalable au patient. Cette démarche, bien qu'elle relève de la responsabilité du service et non du manipulateur stagiaire, constitue un axe d'amélioration pour la prise en charge globale de ces situations.

Enfin, la formation continue des manipulateurs sur la gestion de la communication dans ces contextes sensibles apparaît comme un besoin identifié. L'étude de 2019 précédemment citée souligne qu'un questionnement sur nos pratiques est indispensable et doit être soutenu par un renforcement du lien entre manipulateurs et radiologues pour mieux prendre en charge le patient dans sa globalité.

En conclusion, cette situation, sans difficulté technique particulière, a été particulièrement formatrice. Elle m'a confronté à une réalité essentielle du métier de manipulateur en imagerie médicale : la gestion de l'asymétrie d'information entre le soignant et le patient dans le contexte des découvertes fortuites. Ces situations sont loin d'être exceptionnelles puisqu'elles surviennent dans 15 à 20 % des examens d'imagerie.

Cette expérience m'a permis de comprendre que la maîtrise de la communication non verbale ne repose pas sur un contrôle permanent et conscient, qui devient paradoxalement une source de tension, mais plutôt sur l'intégration progressive de repères professionnels stables et de routines cohérentes. Le respect du cadre déontologique – secret professionnel et délimitation claire des rôles entre manipulateur et radiologue – constitue le socle non négociable de cette posture professionnelle.

Au-delà de ma responsabilité individuelle, cette situation soulève également des enjeux institutionnels. L'information préalable des patients sur la possibilité de découvertes fortuites, la mise en place de consultations post-examen systématiques par le radiologue, et la formation des professionnels à la gestion de ces situations complexes constituent des axes d'amélioration identifiés par la littérature scientifique et les sociétés savantes.

Cette expérience participe ainsi à la construction de ma posture professionnelle. Elle m'aide à trouver un équilibre entre rigueur technique, respect du cadre réglementaire et qualité de la relation soignant-soigné, tout en identifiant les limites de ma pratique actuelle et les ressources institutionnelles à mobiliser pour progresser dans ce métier.

Références bibliographiques

1. **"L'œil du manipulateur sur l'incidentalome au scanner"**
Étude prospective, Hôpital Saint-Joseph, Paris, 2018.
Disponible sur : https://centredoc.chu-tours.fr/index.php?id=49620&lvl=notice_display
2. **KHAMMAR. "Relation soignant/soigné"**
Support de cours IFSI, 2019.
Disponible sur : http://www.univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/ssh1an-relation_soignat_soigne2019khammar.pdf
3. **"Une thèse d'éthique sur les découvertes fortuites en imagerie médicale"**
CCN - Carnets de recherche, hypotheses.org
Disponible sur : <https://ccn.hypotheses.org/624>
4. **"Ces non-dits thérapeutiques qui en disent long"**
Labortho.fr, février 2025.
Cite Guy Barrier, chercheur en analyse gestuelle en sciences de l'information-communication.
Disponible sur : <http://www.labortho.fr/non-dits-therapeutiques/>
5. **THELLIER S., et al. "La relation manipulateur-radiologue avec le patient : expérience dans un département d'imagerie médicale"**
Cancer/Radiothérapie, Volume 23, numéros 6-7, 2019, pages 510-516.
Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0221036309748000>
6. **Code de déontologie médicale - Article R.4127-4 du Code de la santé publique**
Secret professionnel.
Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Disponible sur : <https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-4-secret-professionnel>
7. **Code pénal - Article 226-13**
Violation du secret professionnel.
Légifrance - Service public de la diffusion du droit.
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417944
8. **VOIX Fabien. "Le rôle du manipulateur d'électroradiologie médicale dans l'information donnée au patient"**
Association Française du Personnel Paramédical d'Électroradiologie (AFPPE).
Référence à l'article R4351-3 du Code de la santé publique.
Disponible sur : <https://healthmanagement.org/c/imgfr/issuearticle/le-role-du-manipulateur-d-electroradiologie-medicale-dans-l-information-donnee-au-patient>
9. **Code de la santé publique - Article R4351-3**
Actes professionnels des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Légifrance - Service public de la diffusion du droit.
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006913754
10. **Société Française de Radiologie (SFR). "Éthique de la radiologie et de l'imagerie médicale"**
Intervention du Pr Alain Luciani, janvier 2023.
Journée organisée avec l'Espace Éthique Île-de-France.
Disponible sur : <https://www.radiologie.fr/pratiques-professionnelles/sfr-actu/ethique-la-radiologie-et-limagerie-medicale>

11. **Société Française de Radiologie (SFR). "Les découvertes fortuites : regards croisés entre radiologie et génétique médicale"**
Mai 2024.
Disponible sur : <https://www.radiologie.fr/pratiques-professionnelles/sfr-actu/les-decouvertes-fortuites-regards-croises-entre-radiologie-et>
 12. **Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues (PCsBI). "Anticipate and Communicate: Ethical Management of Incidental and Secondary Findings in the Clinical, Research, and Direct-to-Consumer Contexts"**
December 2013.
Georgetown University Bioethics Archive.
Disponible sur : <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/node/3>
 13. **POMMIER Romain. "De l'incidentalome à la découverte secondaire"**
médecine/sciences, Volume 36, novembre 2020.
Analyse des recommandations PCsBI et définition des incidentalomes.
Disponible sur :
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2020/10/msc200093/msc200093.html
 14. **Olea Medical. "L'importance des découvertes fortuites dans le parcours de soin des patients"**
Novembre 2024.
Données épidémiologiques : 15 à 20% des examens d'imagerie révèlent des découvertes fortuites.
Disponible sur : <https://www.olea-medical.com/fr/limportance-des-decouvertes-fortuites-dans-le-parcours-de-soin-des-patients/>
-

Ressources complémentaires consultées

15. **POMMIER Romain. "Les découvertes fortuites en médecine diagnostique"**
In : Traité de bioéthique IV - Les nouveaux territoires de la bioéthique, érès, 2018, pages 363-376.
Disponible sur : <https://www.cairn.info/traite-de-bioethique-iv--9782749260839-page-363.htm>
16. **"La communication non verbale"**
Cours soignants - Espace soignant.
Travaux d'Albert Mehrabian (1967) et proxémie d'Edward T. Hall (1971).
Disponible sur : <https://www.espacesoignant.com/soignant/soins-relationnels/communication-non-verbale>
17. **"Secret médical et professionnel : définition, exemples et sanctions"**
Service Public - Droits des patients.
Disponible sur : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302>